# EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
# INTERVENCIÓN – PREVENCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ATEROESCLERÓTICA

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **Problema / Necesidad de Salud** | Las enfermedades cardiovasculares (ECV) se encuentran entre las principales causas de muerte en el mundo con un aproximado de 17,9 millones de muertes al año (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2023).<br><br>La enfermedad ateroesclerótica, es uno de los factores de riesgo asociados a las ECV y es una patología que se presenta de forma progresiva, iniciando su proceso desde la infancia (Arroyo et al., 2019). Es por esta razón, que se considera la dislipidemia en niños y adolescentes como uno de los factores de riesgo para presentar enfermedades cardiovasculares en la edad adulta (Noreña-Peña, et al., 2018; OMS, 2023).<br><br>Por otra parte, se ha encontrado que en niños y adolescentes con obesidad existe una mayor prevalencia de la dislipidemia, la cual puede llegar hasta un 62 %, más del doble de la prevalencia máxima encontrada en esta misma población cuando el peso se encuentra en rangos normales (23 %) (Sharma, et al., 2019).<br><br>La importancia de la detección temprana de las dislipidemias radica sobre todo en que existen intervenciones seguras y efectivas que permiten el abordaje de esta patología desde la infancia y en consecuencia llegar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares prematuras (Gidding S., et al., 2022; US Deparment of Health and Human Services [HHS], 2020).<br><br>Como parte de estas intervenciones se ha establecido como primer paso el abordaje por nutrición y posteriormente por pediatría, según sea la severidad del problema (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2016; HHS, 2020). Por otro lado, cuando la dislipidemia se encuentra asociada a sobrepeso u obesidad, se encontró que es mucho más efectivo que, además de la dieta, se implemente un programa que busque el aumento de la actividad física (HHS, 2020). |
| **Evidencia** | El incremento de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en edades tempranas ha llevado a un aumento en la cantidad de niños con dislipidemia, por lo que el Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos junto con el panel de expertos del Instituto Nacional del corazón, pulmones y sangre de Estados Unidos clasifican como altamente recomendado:<br><br>• Tamizaje universal para la dislipidemia en niños entre los 9 y 11 años.<br>• Tamizaje de dislipidemia en niños entre los dos y 8 años con obesidad.<br>• Tamizaje de dislipidemia en adolescentes entre los 12 y 16 años con obesidad.<br><br>Además, recomiendan un segundo tamizaje universal entre los 17 y 19 años (HHS, 2020)<br><br>Por otra parte, un análisis de las políticas europeas para el tamizaje del hipercolesterolemia familiar infantil ha demostrado que el tamizaje universal de la dislipidemia permite identificar más del 90 % de las dislipidemias familiares (Gidding S., et al., 2022). |

| | |
|---|---|
| **Consideraciones de Implementación** | Barreras:<br>Capacidad instalada de los Servicios de laboratorio clínico para realizar el tamizaje de dislipidemia. Consultas en el rango de edad enfocadas a la atención de la morbilidad y desaprovechando la oportunidad del tamizaje. Desconocimiento de los padres y encargados sobre la detección temprana de la dislipidemia en niños y adolescentes.<br><br>Estrategias:<br>Implementación paulatina del tamizaje de dislipidemia en las nuevas poblaciones blanco. Capacitación al personal. Educación en los diferentes escenarios a los padres y encargados sobre la importancia del tamizaje dislipidemia. |
| **Normativa Técnica** | Manual de procedimientos para la atención integral del niño y la niña. Primer nivel de atención. Anexo 17 Manejo de sobrepeso y la obesidad en niñas y niños (CCSS, 2016). |
| **Costo / Efectividad** | Estudios en diferentes países europeos han demostrado que realizar el tamizaje universal de dislipidemia en niños es una intervención de bajo costo por caso, en donde incluso se puede llegar a incrementar hasta 11 años de vida saludable a las personas identificadas como dislipidémicas (Gidding S. et al., 2022). |
| **Objetivo (s) de la Evaluación** | Valorar la detección de la dislipidemia en la población infantil y adolescentes, con el fin de establecer las estrategias pertinentes para la prevención de futuras enfermedades cardiovasculares. |
| **Pregunta (s) de Evaluación** | ¿Cuál es el acceso efectivo de la población infantil y adolescente al tamizaje de dislipidemia?<br><br>¿Cuáles son los grupos de riesgo identificados mediante el tamizaje de dislipidemia?<br><br>¿Cuál es la magnitud de los componentes del perfil de lípidos en alto riesgo según estado nutricional? |
| **Indicadores asociados a la intervención** | 03-04-01.0 Porcentaje de población de nueve a 11 años con tamizaje universal de dislipidemia.<br><br>03-05-01.1 Porcentaje de población de dos a 19 años con obesidad a quienes se les tamiza por dislipidemia. |
| **Anexos** | No aplica |
| **Referencias Bibliográficas** | Arroyo Díez F.J., Romero Albillos J.A., & López Valero G.N. (2019). Dislipemias en edad pediátrica. *Protocolos Diagnósticos y Terapéuticos en Pediatría*. *1*, 125-140. https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/08_dislipemias.pdf<br><br>Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2016). *Manual de procedimientos para la atención del niño y la niña. Primer nivel de atención*. CCSS.<br><br>Gidding, S. S., Wiegman, A., Groselj, U., Freiberger, T., Peretti, N., Dharmayat, K. I., ... & Geanta, M. (2022). Paediatric familial hypercholesterolaemia screening in Europe: public policy background and recommendations. European Journal of Preventive Cardiology, *29*(18), 2301-2311. https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwac200<br><br>National Institutes of Health [NIH]. (2012). Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and adolescents. https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/integrated-guidelines-for-cardiovascular-health-and-risk-reduction-in-children- |

and-adolescents

Noreña-Peña, A., García de las Bayonas López, P., Sospedra López, I., Martínez-Sanz, J. M., & Martínez-Martínez, G. (2018). Dislipidemias en niños y adolescentes: factores determinantes y recomendaciones para su diagnóstico y manejo. *Revista Española de Nutrición Humana y Dietética*, *22*(1), 72-91. https://dx.doi.org/10.14306/renhyd.22.1.373

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2023). *Enfermedades cardiovasculares.* OMS. https://www.who.int/es/health-topics/cardiovascular-diseases#tab=tab_1

Sharma, V., Coleman, S., Nixon, J., Nixon, J., Sharples, L., Hamilton-Shield, J., Rutter, H., Bryant, M. (2019). A systematic review and meta-analysis estimating the population prevalence of comorbidities in children and adolescents aged 5 to 18 years. *Obesity Reviews, 20*, 1341–1349. https://doi.org/10.1111/obr.12904

US Department of Health and Human Services [HHS]. (2020). Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents. https://www.hhs.gov/guidance/document/integrated-guidelines-cardiovascular-health-and-risk-reduction-children-and-adolescents